

Đau Vùng Chậu Do Cơ-Xương

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Đau vùng chậu từ cơ, khớp và dây thần kinh

Một số cơn đau vùng chậu không xuất phát từ bàng quang hay cơ quan sinh sản mà từ **cơ, khớp, dây thần kinh và mô liên kết** của vùng chậu — thường do cơ sàn chậu bị căng cứng, không thể thả lỏng. Đây là tình trạng có thật, phổ biến và có thể điều trị, ngay cả khi kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm đều bình thường.

Về tình trạng này

Cơ sàn chậu có thể bị căng cứng hoặc co thắt, tương tự như một cơ bị co rút ở bất kỳ chỗ nào trên cơ thể. Các biểu hiện thường gặp:

- Đau âm ỉ, cảm giác nặng nề hoặc rát bỏng ở vùng chậu, đáy chậu, lưng dưới hoặc hông
- Đau khi **ngồi**, khi quan hệ tình dục (đau khi giao hợp), khi dùng tampon hoặc khi đại tiện
- **Tiểu gấp hoặc tiểu nhiều lần** do cơ bị căng cứng, không phải do bàng quang

Nguyên nhân

Thường do nhiều yếu tố kết hợp: căng cứng hoặc co thắt cơ, chấn thương, phẫu thuật hoặc sinh con trước đây, tư thế và thói quen, stress (khiến cơ thể siết chặt), và đôi khi do kích thích dây thần kinh vùng chậu. Sàn chậu thường ở trạng thái “ngắn và căng” hơn là yếu — vì vậy việc tập bài tập Kegel mạnh có thể làm tình trạng tệ hơn.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Sàn chậu

Nhóm cơ sàn chậu nâng đỡ các tạng vùng chậu.

Sàn chậu tăng hoạt / căng cứng

Cơ luôn ở trạng thái siết chặt, không thể thả lỏng hoàn toàn.

Đau khi giao hợp

Đau trong hoặc sau hoạt động tình dục.

Điểm kích hoạt

Nút cơ nhạy đau có thể gây đau lan ra vùng khác.

Vật lý trị liệu sàn chậu

Liệu pháp giải phóng và tái huấn luyện các cơ này.

Down-training (thả lỏng)

Tập thư giãn (không phải tăng cường) sàn chậu bị căng.

Dây thần kinh thẹn

Dây thần kinh vùng chậu, khi bị kích thích có thể gây đau.

TẠI SAO KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM BÌNH THƯỜNG MÀ TÔI VẪN ĐAU? Vì cơn đau này xuất phát từ cơ và dây thần kinh, không phải từ nhiễm trùng hay khối u hiển thị trên hình ảnh. Kết quả bình thường là tin tốt — điều đó cho thấy đây là vấn đề cơ có thể điều trị được, không phải điều gì nguy hiểm. Cơn đau không có “hình ảnh” vẫn hoàn toàn có thật.

Chẩn đoán như thế nào

- Khai thác tiền sử: đau ở đâu, khi nào, điều gì làm nặng hơn
- Khám lâm sàng **kiểm tra cơ sàn chậu** nhẹ nhàng tìm điểm đau và căng cứng
- Loại trừ các nguyên nhân khác (nhiễm trùng, v.v.) bằng xét nghiệm đơn giản

Điều trị như thế nào (từng bước)

- 1 **Vật lý trị liệu sàn chậu** là nền tảng — giải phóng cơ thủ công, kéo giãn và thư giãn (“down-training”).
- 2 **Tự chăm sóc** — chườm ấm, vận động nhẹ nhàng, thở thư giãn, điều chỉnh tư thế, giảm táo bón và tránh các chất kích thích bàng quang.
- 3 **Thuốc hoặc tiêm** — thuốc giảm đau thần kinh hoặc tiêm vào điểm kích hoạt.
- 4 **Kiểm soát stress và giấc ngủ**, vì cả hai ảnh hưởng mạnh đến độ căng cơ.

Sống chung với tình trạng này

- Nhận biết và thả lỏng tình trạng **siết chặt** (hàm, mông, sàn chậu) trong suốt ngày.
- Dùng nhiệt và kéo giãn nhẹ nhàng; tránh ngồi cứng lâu.
- Cải thiện thường dần dần qua nhiều tuần điều trị — sự kiên trì rất quan trọng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Đau vùng chậu **dữ dội** mới xuất hiện, hoặc sốt
- Thay đổi mới về đại tiện hoặc tiểu tiện, hoặc tê/yếu ở chân
- Đau sau té ngã hoặc chấn thương, hoặc tiểu ra máu hay phân có máu

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Đau vùng chậu thường do cơ sàn chậu và dây thần kinh căng cứng, tăng hoạt — có thật và có thể điều trị dù xét nghiệm bình thường.
2. Vật lý trị liệu sàn chậu (để thư giãn, không phải tăng cường) là điều trị chính, kết hợp tự chăm sóc, thuốc và kiểm soát stress.
3. Cải thiện là dần dần. Hãy đến gặp bác sĩ nếu có đau dữ dội mới, sốt, tê/yếu chân hoặc thay đổi đại tiểu tiện.